

Vou para o Hospital. E Agora?

Um guia para preparar a ida e a internação da pessoa idosa

Nome do paciente: _____ Data: _____

Uma internação começa antes de chegar ao hospital. Para a pessoa idosa, principalmente quando há fragilidade, algumas informações e cuidados simples fazem muita diferença. Este guia ajuda você a **organizar o que levar, contar à equipe como a pessoa era antes de adoecer, acompanhar mudanças** durante a internação e **preparar uma alta mais segura**. Marque o que já fez.

1. Antes de sair de casa

Se não for uma emergência que exija sair na hora. Em emergência, ligue 192 e peça a alguém que leve estes itens depois.

Documentos

- ☐ Documento de identificação
- ☐ Cartão do SUS ou do convênio
- ☐ Contato do familiar ou responsável
- ☐ Contato dos médicos que acompanham a pessoa
- ☐ Cópia das Diretivas Antecipadas de Vontade, se existir

Informações de saúde

- ☐ Lista atualizada dos remédios, com dose e horário
- ☐ Alergias
- ☐ Principais doenças e cirurgias
- ☐ Internações recentes importantes
- ☐ Exames recentes importantes
- ☐ Suplementos, vitaminas, chás e remédios sem receita (também contam)

Não confie só na memória. Se não houver lista atualizada, fotografe as caixas dos remédios. Se você já preencheu o “Meu Retrato de Saúde”, leve-o: ele cobre boa parte desta lista.

2. Não esqueça o que ajuda a pessoa a funcionar

Para ver, ouvir e comer

- ☐ Óculos
- ☐ Aparelho auditivo, com pilhas ou carregador
- ☐ Dentadura e estojo identificado

Para se locomover e se orientar

- ☐ Bengala ou andador
- ☐ Calçado fechado e antiderrapante
- ☐ Um objeto familiar: foto, relógio pequeno

Identifique tudo com o nome da pessoa. Óculos e aparelho auditivo não são detalhes: enxergar e ouvir bem ajuda a pessoa a entender onde está, a se comunicar e a manter a autonomia. Deixe joias e objetos de valor em casa.

3. Conte à equipe como a pessoa era antes

Essa pode ser a informação mais importante da internação. A equipe conhece a doença de agora; **só a família conhece a pessoa de antes**. Sem esse retrato, uma mudança pode passar por “normal”.

Use o quadro **“Como era antes desta doença”** na ficha da última página: se caminhava, se tomava banho e ia ao banheiro sozinha, como estava a memória, como comia e se havia perda de urina ou fezes. **Entregue a ficha na admissão** e peça que seja anexada ao prontuário.

4. Durante a internação

Ajude a preservar o que a pessoa ainda tem. Tratar a doença é o mais importante, mas a própria internação pode tirar função: muitos idosos saem do hospital menos capazes do que entraram. Quando a equipe permitir:

- ☐ **Fique com a pessoa sempre que possível.** O Estatuto da Pessoa Idosa (art. 16) assegura ao idoso internado o direito a acompanhante, em tempo integral, segundo o critério médico.
- ☐ **Óculos, aparelho auditivo e dentadura** sempre à mão, e a dentadura nas refeições.
- ☐ **Orientação e sono:** diga o dia, o horário e onde ela está; deixe relógio e calendário à vista. À noite, luz baixa e menos barulho, quando possível.
- ☐ **Sentar, levantar e caminhar** quando liberado, sempre com ajuda. O risco de queda é maior no hospital.
- ☐ **Refeições:** veja se a bandeja foi aberta, se a pessoa enxerga o prato e consegue mastigar e engolir. Avise se comer ou beber diminuiu.
- ☐ **Urina e intestino:** pergunte se a fralda ou a sonda são mesmo necessárias. Sempre que possível, banheiro ou cadeira sanitária.
- ☐ **Pele e dor:** olhe calcanhares e região do cóccix; mancha vermelha que não some deve ser comunicada. Quem não consegue dizer que dói mostra com careta, agitação ou recusa de se mexer.
- ☐ **Autonomia:** deixe a pessoa fazer o que ainda consegue (comer, se lavar, se vestir em parte).

5. Atenção à confusão aguda (delirium)

A pessoa que conversava normalmente pode, durante uma doença ou uma internação, ficar:

- ☐ Confusa ou desorientada
- ☐ Agitada
- ☐ Muito sonolenta
- ☐ Diferente do comportamento habitual
- ☐ Alternando agitação e sonolência

Isso pode ser **delirium**: uma complicação comum do idoso internado, que quase sempre tem uma causa a procurar e tratar (infecção, desidratação, remédio, dor, urina presa, falta de sono). **Não aceite “é da idade” nem “é a demência”**. Mesmo quem já tem demência pode piorar de repente. **Avise a equipe na hora.**

6. Os remédios mudaram?

Na internação, remédios podem ser suspensos, trocados ou acrescentados. Pergunte:

- ☐ Quais remédios de casa foram mantidos?
- ☐ Quais foram suspensos?
- ☐ Quais são novos?
- ☐ Algum é só temporário? **Remédio para dormir ou para agitação, começado no hospital: até quando, e quem vai suspender?**
- ☐ Como fica a prescrição depois da alta?

Não dê remédios de casa durante a internação sem a equipe saber (inclusive chás e suplementos). E evite manter a receita antiga e a nova ao mesmo tempo sem conferir as diferenças.

7. Antes da alta

Não espere chegar em casa para descobrir o que faltou perguntar.

Remédios e cuidados

- ☐ Tenho a receita atualizada
- ☐ Sei quais remédios foram retirados e quais foram acrescentados
- ☐ Entendi doses e horários
- ☐ Sei cuidar de curativos, sondas ou outros dispositivos
- ☐ Entendi as orientações de alimentação
- ☐ Sei quais atividades estão liberadas

Recuperação e seguimento

- ☐ Sei se precisa de fisioterapia ou reabilitação
- ☐ Sei se precisa de equipamentos ou adaptações em casa (cama, cadeira de banho, andador)
- ☐ Tenho o **resumo de alta por escrito**
- ☐ Tenho os retornos marcados, com **consulta com quem acompanha a pessoa na primeira ou segunda semana**
- ☐ Sei quais exames estão pendentes
- ☐ Sei quem vai cuidar nos primeiros dias em casa e como nos revezar

A primeira semana em casa é a mais delicada. Se algo mudar, consulte o guia “Sinais que Não Esperam”: uma mudança súbita não deve ser atribuída à idade.

8. A pergunta que não pode faltar

Compare com o período anterior à doença. A pessoa voltou a ser como era antes da internação?

- ☐ Caminha como antes
- ☐ Está lúcida como antes
- ☐ Levanta como antes
- ☐ Faz suas atividades como antes
- ☐ Come como antes

“O que precisamos fazer para recuperar o que foi perdido?”

Se a resposta for não, faça esta pergunta à equipe. **A alta encerra a internação. Nem sempre encerra a recuperação.**

Para levar ao hospital

Preencha com antecedência. **Entregue à equipe na admissão e peça que seja anexada ao prontuário.**

Nome completo _____

Data de nascimento _____

Como gosta de ser chamado(a) _____

Contato principal (nome e telefone) _____

Quem decide se ela não puder _____

Alergias _____

☐ Tem Diretivas Antecipadas de Vontade (cópia anexa)

Medicamentos em uso

Medicamento	Dose	Horários

Anticoagulante, insulina ou outro que não pode atrasar _____

Suplementos, chás e remédios sem receita _____

Principais doenças e cirurgias _____

Como era antes desta doença

Anda	☐ sozinha	☐ bengala ou andador	☐ com ajuda	☐ não anda
Banho, vestir, banheiro	☐ sozinha	☐ com ajuda		
Memória	☐ lúcida	☐ esquecimentos leves	☐ demência	☐ já ficou confusa numa internação
Come	☐ sozinha	☐ com ajuda	☐ dieta modificada	☐ dificuldade de engolir
Urina e fezes	☐ continente	☐ perde urina	☐ perde fezes	☐ usa fralda
Usa	☐ óculos	☐ aparelho auditivo	☐ dentadura	

O que mudou agora _____

O que acalma ou ajuda (música, oração, foto...) _____

Este material é educativo e **não substitui as orientações da equipe responsável pelo atendimento.** Preenchido em ____/____/____ por _____.